

FICHE PRATICIEN NATUROPATHE

Régulation glycémique et accompagnement des troubles métaboliques

VALEURS DE RÉFÉRENCE

Paramètre	Normal	Prédiabète	Diabète
Glycémie à jeun	0,8-1 g/L	1-1,26 g/L	≥1,26 g/L
Glycémie aléatoire	< 1,4 g/L	-	≥2 g/L
HbA1c	< 5,7%	5,7-6,4%	≥6,5%
Hypoglycémie	-	-	<0,7 g/L

DÉPISTAGE ET ORIENTATION

Signes d'alerte **DIABÈTE TYPE 1** (urgence médicale)

Les 4 "P" : Polyurie + Polydipsie + Polyphagie + Perte de poids → **Orientation médicale immédiate**

Signes d'alerte **INSULINORÉSISTANCE** (intervention précoce)

- Obésité abdominale (tour de taille ♂>94cm, ♀>80cm)
- Fatigue post-prandiale, "coups de pompe"
- Fringales, compulsions sucrées
- Difficulté à perdre du poids
- SOPK chez la femme
- Acanthosis nigricans (peau foncée plis)

Marqueurs biologiques à demander

Priorité 1 (dépistage précoce) :

- **Indice HOMA** (glycémie + insulémie à jeun)
- Bilan lipidique (TG, HDL)
- Tour de taille

Suivi diabète déclaré :

- HbA1c (tous les 3 mois)
- Peptide C (sécrétion insuline)

PHYSIOPATHOLOGIE SIMPLIFIÉE

Régulation normale

HYPERGLYCÉMIE → Insuline ↑ → Entrée glucose cellules → Glycémie ↓
HYPOGLYCÉMIE → Glucagon ↑ → Production glucose foie → Glycémie ↑

Évolution vers diabète type 2

1. Obésité viscérale + Sédentarité + Inflammation
2. INSULINORÉSISTANCE (tissus "sourds" à l'insuline)
3. Hyperinsulinisme compensateur (pancréas travaille plus)
4. Épuisement pancréatique progressif
5. DIABÈTE TYPE 2 (hyperglycémie + insulino-pénie)

⚠ **Point clé** : L'insulinorésistance précède de **plusieurs années** l'hyperglycémie. C'est le moment d'agir !

ACCOMPAGNEMENT NATUROPATHIQUE

PHASE 1 : Prévention insulinorésistance

Alimentation

Principes :

- Privilégier **charge glycémique basse** (pas seulement IG)
- Répartition : légumes 50%, protéines 25%, glucides complexes 25%
- Fibres à chaque repas (ralentissent absorption)
- Éviter grignotages (laisser pancréas au repos)

Aliments favorables :

- Céréales complètes (pas raffinées)
- Légumineuses (lentilles, pois chiches)
- Légumes verts à volonté
- Fruits entiers (avec fibres), 2-3/jour
- Bonnes graisses (oméga-3, noix, huile olive)
- Protéines de qualité à chaque repas

À limiter/éviter :

- Sucres rapides isolés
- Farines raffinées (pain blanc, pâtes blanches)
- Produits ultra-transformés
- Excès de fructose (sirops, jus de fruits)

Micronutrition

Priorités insulino-résistance :

- **Magnésium** 300-400mg/j (cofacteur 300 réactions, sensibilité insuline)
- **Chrome** 200µg/j (métabolisme glucides)
- **Zinc** 15-30mg/j (signalisation insuline)
- **Oméga-3** EPA/DHA 1-2g/j (anti-inflammatoire)
- **Vitamine D** (statut optimal >30ng/mL)
- **Berbéryne** 500mg x3/j (équivalent metformine naturel)

Plantes :

- Cannelle (sensibilité insuline)
- Gymnema sylvestris (réduction envies sucrées)
- Fenugrec (régulation glycémie)
- Curcuma (anti-inflammatoire)

Activité physique +++

Pourquoi c'est crucial : L'exercice permet l'expression des GLUT4 **indépendamment de l'insuline** !

Prescription minimum :

- 30 min/j activité modérée (marche rapide)
- 2-3 séances renforcement musculaire/semaine
- Éviter sédentarité prolongée (se lever toutes les 90min)

Timing optimal : Courte marche post-prandiale (15-20min après repas)

Gestion stress & sommeil

- Stress chronique → cortisol ↑ → hyperglycémie
- Sommeil < 7h → résistance insuline ↑
- Cohérence cardiaque 3x/j
- Sommeil régulier, coucher avant 23h

PHASE 2 : Diabète déclaré (complément médical obligatoire)

Rôle du naturopathe

⚠ Collaboration médicale indispensable

- Ne jamais interrompre traitement médical
- Adapter conseils aux traitements en cours
- Surveillance glycémique rigoureuse

Éducation charge glycémique

Exemples pratiques :

- Préférer riz basmati au riz blanc
- Patate douce > pomme de terre
- Pâtes al dente > trop cuites
- Toujours associer protéines + fibres + bonnes graisses

Gestion hypoglycémies (sous traitement)

Resucrage d'urgence (15g glucides) :

- 3 morceaux de sucre, OU
- 15cl jus de fruit/soda, OU
- 1 c. à soupe miel/confiture

Contrôle après 15 min → renouveler si besoin

⚠ Ne jamais conduire en hypoglycémie

Prévention complications

Microangiopathie (yeux, reins, nerfs) :

- Contrôle glycémique strict (HbA1c <7%)
- Antioxydants (vitamine E, acide alpha-lipoïque)
- Protection rénale (limitation protéines si nécessaire)

Macroangiopathie (cœur, cerveau) :

- Contrôle tous facteurs CV (TA, lipides, poids)
- Oméga-3 +++
- Activité physique adaptée

PROTOCOLE TYPE CONSULTATION

☐ Anamnèse ciblée

- Antécédents familiaux diabète
- Évolution pondérale
- Habitudes alimentaires (3 jours types)
- Activité physique réelle
- Qualité sommeil, gestion stress
- Symptômes : fatigue, fringales, soif, urines

2 Mesures anthropométriques

- Poids, IMC
- **Tour de taille** (marqueur obésité viscérale)
- Composition corporelle si possible

3 Bilan biologique recommandé

Première consultation :

- Glycémie à jeun + Insulinémie (→ HOMA)
- Bilan lipidique complet
- HbA1c si diabète suspecté

Suivi : Tous les 3-6 mois selon profil

4 Objectifs personnalisés

Court terme (3 mois) :

- Perte pondérale 5-10% si surpoids
- Activité physique régulière installée
- Amélioration habitudes alimentaires

Moyen terme (6-12 mois) :

- Normalisation HOMA
 - HbA1c < 6,5% (prédiabète) ou <7% (diabète)
 - Amélioration bilan lipidique
-

⚠️ **DRAPEAUX ROUGES - ORIENTATION MÉDICALE**

Urgence immédiate :

- Signes acidocétose (haleine pomme, confusion, douleurs abdominales)
- Hypoglycémie sévère ($< 0,5$ g/L, troubles conscience)
- Déshydratation majeure

Orientation rapide :

- Glycémie à jeun $> 1,26$ g/L (2 mesures)
- Symptômes 4P brutaux
- HbA1c $> 6,5\%$
- Complications débutantes (vision floue, plaies qui cicatrisent mal)

Collaboration :

- Ajustement traitements hypoglycémiants
 - Objectifs glycémiques individualisés
 - Bilan complications annuel
-

💡 **MESSAGES CLÉS POUR VOS CONSULTANTS**

1. **"Le diabète type 2 ne survient pas du jour au lendemain"** → L'insulinorésistance est détectable des années avant → C'est le moment d'agir !
 2. **"Ce n'est pas QUE le sucre"** → Obésité viscérale + sédentarité + inflammation sont les vrais coupables → Approche globale indispensable
 3. **"Bouger = médicament naturel"** → L'exercice fait entrer le glucose sans insuline → Minimum 30min/jour, non négociable
 4. **"Stabilisé $\neq$ Guéri"** → Le travail de fond continue (inflammation, insulinorésistance) → Hygiène de vie à vie
 5. **"Chaque repas compte"** → Charge glycémique basse systématique → Associer protéines + fibres + bonnes graisses
-

Concepts avancés

- **1ère phase insulinique** : cruciale, son altération prédit le diabète
- **GLP-1 endogène** : sécrété par intestin après repas, potentialise insuline
- **Glucokinase** : "capteur" glucose pancréatique, défaut = diabète MODY-2
- **Tissu adipeux viscéral** : organe endocrinien inflammatoire

Interactions médicamenteuses

- **Bêta-bloquants** : masquent hypoglycémies, inhibent glycogénolyse
 - **Corticoïdes** : hyperglycémisants puissants
 - **Certains antipsychotiques** : favorisent insulino-résistance
-

✓ CHECKLIST CONSULTATION INSULINO-RÉSISTANCE/DIABÈTE

- ☐ Anamnèse complète (alimentation, activité, antécédents)
 - ☐ Mesure tour de taille
 - ☐ Demande HOMA + bilan lipidique (si non fait)
 - ☐ Évaluation charge glycémique habitudes actuelles
 - ☐ Programme alimentaire personnalisé
 - ☐ Prescription activité physique adaptée
 - ☐ Complémentation ciblée (Mg, Cr, Oméga-3)
 - ☐ Travail sommeil & stress
 - ☐ Objectifs SMART définis
 - ☐ RDV suivi 1 mois (puis adaptation)
 - ☐ Coordination avec médecin si diabète déclaré
-

Dernière mise à jour : Décembre 2025

Sources : Physiologie de la régulation glycémique - Formation professionnelle